

Sumário

PROTOCOLOS DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL: DERMATOLOGIA.....	3
Mudanças da nova versão	5
Protocolo 1 – Acne.....	6
Protocolo 2 – Câncer de Pele Melanoma.....	7
Protocolo 3 – Câncer de Pele Não Melanoma, Ceratoses Actínicas e Lesões Benignas de Pele e Tecido Subcutâneo...8	
Protocolo 4 – Dermatite Atópica	10
Protocolo 5 – Outros Eczemas ou Dermatites (Dermatite Seborreica, Dermatite de Contato, Eczema Disidrótico e Eczema de Estase).....	11
Protocolo 6 – Micoses.....	12
Protocolo 7 – Psoríase.....	13
Protocolo 8 – Alopecia	14
Protocolo 9 – Urticária e Angioedema.....	15
Protocolo 10 – Prurido	16
Protocolo 11 – Condiloma Acuminado, Verrugas Virais e Molusco Contagioso	17
Protocolo 12 – Rosácea.....	18
Protocolo 13 – Melasma	19
Protocolo 14 – Vitiligo	20
Protocolo 15 – Hanseníase.....	21
Protocolo 16 – Anormalidades Cicatriciais (Queloides e Cicatriz Hipertrófica).....	22
REFERÊNCIAS.....	23
APÊNDICES – QUADROS AUXILIARES	30

Protocolos de Regulação Ambulatorial: Dermatologia

O protocolo de Dermatologia foi publicado como parte integrante da [Estratégia RegulaSUS](#) de otimização do acesso à atenção especializada. Os motivos de encaminhamento selecionados são os mais prevalentes para a especialidade Dermatologia. Ressaltamos que outras situações clínicas, ou mesmo achados na história e no exame físico dos pacientes, podem justificar a necessidade de encaminhamento e podem não estar contempladas nos protocolos. Solicitamos que todas as informações consideradas relevantes sejam relatadas, incluindo a expectativa do médico assistente com o encaminhamento.

As informações do conteúdo descritivo mínimo devem ser suficientes para caracterizar a indicação do encaminhamento e sua prioridade, além de contemplar a utilização dos recursos locais para avaliação e tratamento do caso. O resultado de exames complementares é uma informação importante para auxiliar o trabalho da regulação e deve ser descrito quando realizado pelo paciente. Sua solicitação consta no conteúdo descritivo mínimo de cada protocolo. Contudo, os referidos exames não são obrigatórios para os locais sem esses recursos e sua falta não impede a solicitação de consulta especializada.

Pacientes com suspeita ou diagnóstico de neoplasia maligna cutânea devem ser direcionados preferencialmente a serviços de Oncologia. Aqueles com doenças vesicobolhosas (p. ex. pênfigo vulgar), erupções pustulosas, farmacodermias graves, eritrodermias (que não necessitem de internação), dermatite atópica grave, psoríase grave, acne grave, alopecia areata rapidamente progressiva, alopecias cicatriciais, micose subcutânea ou sistêmica, vitiligo rapidamente progressivo ou hanseníase devem ter preferência no encaminhamento para a Dermatologia, quando comparados com outras condições previstas neste protocolo.

Os pacientes com critérios para encaminhamento para Oncologia devem ser atendidos nas agendas oncológicas, respeitando-se as referências regionais de cada município, de acordo com o Plano Estadual de Oncologia, conforme a legislação vigente. O nome das agendas oncológicas por especialidades ou sistemas pode variar de acordo com as referências regionais estabelecidas nos UNACONS/CACONS, estando apresentadas neste protocolo conforme a portaria SAES/MS nº 1.399, de 17 de dezembro de 2019.

As seguintes patologias são benignas, sendo sua retirada considerada estética (realizada exclusivamente para melhorar a aparência), e não está prevista pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em virtude da observância às prioridades e necessidades patológicas:

- ceratose seborreica;
- xantelasma;
- siringoma;
- nevo rubi;
- acrocórdon/fibroma mole;
- nevo melanocítico sem suspeita de neoplasia ou sinais de alarme;
- cicatriz considerada inestética, mas sem componente hipertrófico ou queloidiano.

Excetuam-se os casos em que o dano físico estético resulta de atos de violência contra a mulher, como previsto na Lei Estadual nº 13.448, de 22 de abril de 2010. Ocasionalmente, outros casos graves e especiais envolvendo os procedimentos acima podem ser discutidos e autorizados, quando houver grande prejuízo psicológico ou funcional. Algumas doenças dermatológicas crônicas cursam com prejuízo exclusivamente estético, mas demandam tratamento e acompanhamento continuado, como vitiligo, acne e melasma. Os critérios para encaminhamento dessas condições constam nos protocolos a seguir.

Algumas condições de saúde mais comuns, que necessitam encaminhamento para serviços de urgência/emergência, são contempladas nesses protocolos. Entretanto, ressaltamos que existem outras condições que não foram contempladas. É responsabilidade do médico assistente tomar essa decisão e orientar o encaminhamento para o serviço apropriado, conforme sua avaliação.

Atenção: oriente o paciente e/ou responsável para que leve, na primeira consulta ao serviço especializado, o documento de referência com as informações clínicas e o motivo do encaminhamento, as receitas dos medicamentos em uso e os exames complementares recentes.

Elaborado em 4 de janeiro de 2018.

Última revisão em 5 de maio de 2023.

Protocolo 1 – Acne

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Dermatologia:

- acne fulminans (acne com nódulos e placas de surgimento súbito, crostas hemorrágicas com ou sem febre e artralgias);
- acne conglobata (acne nodular grave, com drenagem de secreção, trajetos fistulosos e cicatrizes);
- acne leve a moderada, com prejuízo na qualidade de vida e com falha no tratamento clínico otimizado realizado por pelo menos 4 meses (antibioticoterapia sistêmica associada a tratamentos tópicos - [quadro 1](#) e [quadro 2](#)).

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:

1. descrição do quadro clínico:
 - a. tipo (comedões, pápulas, pústulas, nódulos, cistos);
 - b. distribuição (localização);
 - c. tempo de evolução;
 - d. gravidade (leve, moderada ou grave);
 - e. apresenta sintomas sistêmicos como febre ou artralgia (sim ou não). Se sim, descreva;
2. anexar fotografias das lesões;
3. tratamentos já realizados (medicações tópicas e sistêmicas com o tempo de tratamento);
4. número da teleconsultoria, se o caso já foi discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

Protocolo 2 – Câncer de Pele Melanoma

Atenção: pessoas com suspeita clínica de melanoma ([quadro 3](#)) devem ser avaliadas em serviços de referência com brevidade. Entre em contato com o TelessaúdeRS-UFRGS, pelo canal 0800 644 6543, para discussão clínica e definição de necessidade de encaminhamento.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Dermatologia:

- nevo melanocítico congênito com mais de 20 cm;
- dois ou mais nevos melanocíticos congênitos com mais de 1,5 cm;
- seguimento clínico de melanoma prévio;
- pacientes com alto risco para desenvolver melanoma ([quadro 4](#)).

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Oncologia Cirurgia Pele:

- melanoma confirmado em anatomopatológico, se necessária investigação de linfonodo sentinela ([quadro 6](#));
- melanoma confirmado em anatomopatológico, sem indicação de investigação de linfonodo sentinela ([quadro 6](#)), se ampliação de margens não puder ser realizada na APS ou na Dermatologia ([quadro 7](#));
- suspeita clínica de melanoma ([quadro 3](#)).

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Oncologia Cirurgia Cabeça e Pescoço:

- lesão bucal com suspeita clínica de melanoma;
- melanoma em região bucal confirmado em anatomopatológico.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Oncologia Clínica e Quimioterapia:

- paciente com melanoma avançado, com metástase(s) a distância.

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:

1. descrição do quadro clínico:
 - a. localização;
 - b. tamanho em cm;
 - c. características (assimetria, bordas, cores, crescimento);
 - d. ulceração (sim/não);
 - e. tempo de evolução;
2. anexar fotografias da lesão;
3. anexar laudo de exame anatomopatológico, preferencialmente, ou descrever na íntegra seus resultados (se biópsia incisional ou excisional, resultado e informação sobre margens cirúrgicas), com data (se realizado);
4. apresenta alto risco para desenvolver melanoma (sim ou não). Se sim, descreva os fatores ([quadro 4](#));
5. número da teleconsultoria, se o caso já foi discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

Protocolo 3 – Câncer de Pele Não Melanoma, Ceratoses Actínicas e Lesões Benignas de Pele e Tecido Subcutâneo

As especialidades mais indicadas para o tratamento de lesões de pele benignas, malignas e suspeitas com necessidade de tratamento cirúrgico estão resumidas no [quadro 7](#). Atentar para as ofertas regionais, especialmente casos com necessidade de cirurgias ambulatoriais, realização de biópsia e cirurgia geral de média complexidade.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Dermatologia:

- lesões suspeitas ou malignas¹ pequenas (até 2 cm em tronco e membros, ou até 1 cm em face e pescoço), com indicação de remoção cirúrgica;
- lesões com necessidade de biópsia incisional diagnóstica antes da definição terapêutica (diagnóstico diferencial de lesão tumoral, inflamatória ou infecciosa; ex: lúpus, micose profunda, micobacteriose);
- tumores de unhas;
- suspeita ou diagnóstico de ceratose actínica:
 - refratária ao tratamento clínico otimizado ([quadro 8](#)); ou
 - em pacientes imunossuprimidos (por medicamentos, HIV, transplantados, imunodeficiências primárias); ou
 - lesões hiperkeratóticas que impossibilitem o tratamento tópico;
- lesões benignas (lipoma e cisto epidérmico/"sebáceo") pequenas (até 2 cm em tronco e membros, ou até 1 cm em face e pescoço), com prejuízo psicológico ou funcional e desejo de remoção cirúrgica, quando não abordadas na APS ou em agenda de Cirurgia Ambulatorial.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Oncologia Cirurgia Pele:

- tumores com suspeita de malignidade¹, localizados em:
 - tronco e membros: maiores do que 2 cm; ou
 - face e pescoço: maiores do que 1 cm;
 - em áreas difíceis ou especiais (face, orelhas, articulações);
- diagnóstico de câncer de pele não melanoma, confirmado em anatomopatológico com indicação de remoção cirúrgica¹;
- diagnóstico de câncer de pele não melanoma, confirmado em anatomopatológico, com necessidade de radioterapia adjuvante ou investigação de disseminação linfonodal, quando indicada por dermatologista;
- metástase cutânea;
- suspeita ou diagnóstico de tumores de pele agressivos (ex: dermatofibrossarcoma protuberans, carcinoma de Merkel);
- tumores irremovíveis com indicação de cirurgia higiênica (infecções recorrentes com odor fétido, sangramento, dor, piora funcional importante, necrose extensa).

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Cirurgia Geral:

- lesões benignas (lipoma, cisto epidérmico/"sebáceo") grandes (> 5 cm), não localizadas em áreas difíceis ou especiais (face, orelhas ou articulações), com desejo de remoção cirúrgica;
- onicocriptose (unha encravada) com indicação cirúrgica, quando não abordada na APS ou em agenda de cirurgia ambulatorial.

¹Pacientes com neoplasia maligna de pele não melanoma - carcinoma espinocelular *in situ* (Doença de Bowen) ou carcinoma basocelular - que foram tratados cirurgicamente e apresentam margens livres ao exame anatomopatológico, mesmo que descritas como exíguas, não apresentam indicação de encaminhamento oncológico. Recomenda-se que estes casos mantenham acompanhamento médico na APS.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para serviço de Cirurgia Ambulatorial:

- lesões benignas (lipoma ou cisto epidérmico/"sebáceo") pequenas (até 5 cm), com prejuízo psicológico ou funcional e desejo de remoção cirúrgica, quando não abordadas na APS.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Cirurgia Plástica:

- lesões benignas (lipoma, cisto epidérmico/"sebáceo"), localizadas em áreas difíceis ou especiais (face, orelhas, articulações), com desejo de remoção cirúrgica, quando não abordadas em agenda de Dermatologia ou Cirurgia Ambulatorial;
- lesões suspeitas de malignidade localizadas em áreas difíceis ou especiais (face, orelhas, articulações) ou lesões complexas, extensas ou profundas, com alta probabilidade de necessitar de retalho ou enxerto, quando não abordadas em agenda de Oncologia Cirurgia Pele.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Oncologia Cirurgia Cabeça e Pescoço:

- lesões labiais ou em cavidade bucal com suspeita de malignidade;
- diagnóstico de neoplasia maligna labial ou em cavidade bucal, confirmado em anatomopatológico com indicação de remoção cirúrgica.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Estomatologia:

- lesões labiais ou em cavidade bucal, pequenas ou superficiais, com necessidade de biópsia incisional diagnóstica antes da definição terapêutica (diagnóstico diferencial de lesão tumoral, inflamatória ou infecciosa; ex: lúpus, micose profunda, micobacteriose).

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Oftalmologia:

- lesões palpebrais benignas;
- lesões palpebrais malignas¹ ou suspeitas de malignidade, quando não abordadas em agenda de Oncologia Cirurgia Pele.

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:

1. descrição do quadro clínico:
 - a. localização;
 - b. tamanho em cm;
 - c. cor(es);
 - d. presença de ulceração (sim ou não);
 - e. tempo de evolução;
2. anexar fotografias da lesão;
3. anexar laudo de exame anatomopatológico, preferencialmente, ou descrever na íntegra seus resultados (se biópsia incisional ou excisional, resultado e informação sobre margens cirúrgicas), com data (se realizado);
4. se ceratose actínica, descreva tratamentos realizados;
5. presença de imunossupressão (sim ou não). Se sim, descreva;
6. número da teleconsultoria, se o caso já foi discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

¹Pacientes com neoplasia maligna de pele não melanoma - carcinoma espinocelular *in situ* (Doença de Bowen) ou carcinoma basocelular - que foram tratados cirurgicamente e apresentam margens livres ao exame anatomopatológico, mesmo que descritas como exíguas, não possuem indicação de encaminhamento oncológico. Recomenda-se que estes casos mantenham acompanhamento médico na APS.

Protocolo 4 – Dermatite Atópica

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para urgência/emergência:

- eczema herpeticum grave¹, sobreposto às lesões de dermatite atópica;
- infecção bacteriana secundária (impetiginização) grave e extensa, sem resposta à antibioticoterapia sistêmica oral.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Dermatologia:

- dermatite atópica grave e extensa²;
- dermatite atópica que ocasione prejuízo funcional grave (índice de qualidade de vida maior que 10 - [quadro 9](#), para adultos, ou [quadro 10](#), para crianças e adolescentes);
- dermatite atópica refratária ao tratamento clínico otimizado contínuo por um período de 1 mês ([quadro 11](#));
- dermatite atópica recidivante (3 ou mais recidivas em um período de 6 meses), apesar do tratamento clínico otimizado ([quadro 11](#)).

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Imunologia ou Gastroenterologia Pediátrica:

- dermatite atópica com suspeita de alergia alimentar associada a:
 - quadros extensos e de difícil controle, refratários ao tratamento clínico otimizado ([quadro 11](#)), associados ou não a sinais e sintomas sistêmicos como: vômitos, diarreia e atraso do crescimento/desenvolvimento;
 - exacerbações da doença dentro de minutos a poucas horas após o consumo de determinados alimentos.

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:

1. descrição do quadro clínico:
 - a. lesões e localização;
 - b. tempo de evolução;
 - c. outros sinais e sintomas associados;
2. anexar fotografias de todas as áreas cometidas;
3. paciente apresenta prejuízo funcional (sim ou não). Se sim, descreva o índice de qualidade de vida (DLQI - [quadro 9](#) ou CDLQI - [quadro 10](#));
4. tratamento em uso ou já realizado para dermatite atópica (medicamentos utilizados com dose, posologia e tempo de uso);
5. número da teleconsultoria, se o caso já foi discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

¹Eczema herpeticum grave: novas lesões vesico-pustulares, erosões e crostas hemorrágicas acometendo extensamente a superfície cutânea, com repercussão sistêmica, como febre e linfadenopatia.

²Áreas disseminadas de pele seca, prurido intenso e incessante (com ou sem escoriações, espessamento da pele, sangramento, fissuras, exsudação e alteração da pigmentação).

Protocolo 5 – Outros Eczemas ou Dermatites (Dermatite Seborreica, Dermatite de Contato, Eczema Disidrótico e Eczema de Estase)

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Dermatologia:

- eczemas graves e extensos ou que ocasionem prejuízo funcional grave (índice de qualidade de vida maior que 10 - [quadro 9](#), para adultos, ou [quadro 10](#), para crianças ou adolescentes);
- eczemas refratários ao tratamento clínico otimizado, conforme o tipo de eczema ([quadro 13](#)).

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:

1. descrição do quadro clínico:
 - a. lesões e localização;
 - b. tempo de evolução;
 - c. outros sinais e sintomas associados;
2. anexar fotografias de todas as áreas acometidas;
3. paciente apresenta prejuízo funcional (sim ou não). Se sim, descreva o índice de qualidade de vida (DLQI - [quadro 9](#) ou CDLQI - [quadro 10](#));
4. tratamento em uso ou já realizado (medicamentos utilizados com dose, posologia e tempo de uso);
5. número da teleconsulta, se o caso já foi discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

Protocolo 6 – Micoses

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Dermatologia:

- suspeita clínica ou diagnóstico confirmado de micose subcutânea ([quadro 14](#));
- candidíase mucocutânea, dermatofitoses (tineas) ou pitíriase versicolor, se:
 - quadro extenso em pacientes imunocomprometidos (por medicamentos, HIV, imunodeficiências primárias); ou
 - refratária ao tratamento clínico otimizado ([quadro 15](#), [quadro 16](#) e [quadro 17](#));
- onicomicose refratária ao tratamento clínico otimizado ([quadro 18](#)) e com pelo menos 1 dos critérios:
 - episódios de erisipela ou celulite no membro ipsilateral; ou
 - presença de dor ou desconforto; ou
 - suspeita de alteração ungueal não associada à infecção fúngica.

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:

1. descrição do quadro clínico:
 - a. descrição das lesões e localização;
 - b. localização;
 - c. tempo de evolução.
2. anexar fotografias de todas as áreas acometidas;
3. anexar laudo de exame confirmatório (como cultura ou exame micológico direto), preferencialmente, ou descrever na íntegra seus resultados, com data (se realizado);
4. tratamento em uso ou tratamentos já realizados para a infecção fúngica (medicamentos utilizados com dose e tempo de uso);
5. paciente apresenta imunossupressão (sim ou não). Se sim, descreva;
6. episódio prévio de erisipela ou celulite (sim ou não). Se sim, descreva localização e quantidade de episódios;
7. número da teleconsultoria, se o caso já foi discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

Protocolo 7 – Psoríase

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para urgência/emergência:

- suspeita ou diagnóstico de psoríase pustulosa generalizada ([quadro 19](#));
- suspeita ou diagnóstico de psoríase eritrodérmica com instabilidade hemodinâmica ou sinais de infecção sistêmica ([quadro 19](#)).

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Dermatologia:

- suspeita ou diagnóstico de psoríase pustulosa generalizada ([quadro 19](#)), após avaliação em serviço de urgência/emergência;
- suspeita ou diagnóstico de psoríase eritrodérmica ([quadro 19](#));
- psoríase extensa (mais de 10% da área de superfície corporal - BSA¹);
- psoríase que ocasione prejuízo funcional grave (índice de qualidade de vida maior que 10 - [quadro 9](#), para adultos, ou [quadro 10](#), para crianças e adolescentes);
- psoríase refratária ou sem resposta satisfatória ao tratamento tópico otimizado por 3 meses ([quadro 20](#) e [quadro 21](#)).

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Reumatologia:

- diagnóstico de artrite psoriásica ([quadro 22](#));
- suspeita de artrite psoriásica ([quadro 23](#)).

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:

1. descrição do quadro clínico:
 - a. lesões e localização;
 - b. tempo de evolução;
 - c. estimativa da área de superfície corporal acometida (BSA¹);
 - d. outros sinais e sintomas associados;
2. anexar fotografias de todas as áreas acometidas;
3. paciente apresenta prejuízo funcional (sim ou não). Se sim, descreva o índice de qualidade de vida (DLQI - [quadro 9](#) ou CDLQI - [quadro 10](#));
4. tratamento em uso ou já realizado para a psoríase (medicamentos utilizados com posologia e tempo de uso);
5. número da teleconsultoria, se o caso já foi discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

¹Área de superfície corporal (*body surface area* - BSA): considera a palma da mão do paciente, com os dedos unidos, correspondente a 1% da superfície corporal total.

Protocolo 8 – Alopecia

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Dermatologia:

- alopecias cicatriciais ([quadro 24](#));
- alopecia areata com mais de 30% da área do couro cabeludo acometida;
- alopecia areata ofiásica (alopecia em faixa nas regiões laterais e occipital do couro cabeludo);
- alopecia areata refratária ao tratamento tópico otimizado por 3 meses ([quadro 24](#));
- alopecia androgenética refratária ao tratamento clínico otimizado por 12 meses ([quadro 24](#));
- queda de cabelo há pelo menos 6 meses, com teste de tração positivo¹, na ausência de fatores desencadeantes ([quadro 24](#)).

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:

1. descrição do quadro clínico:
 - a. descrição da queda de cabelo (alopecia em placas/difusa, eritema, pústulas, descamação);
 - b. tempo de evolução;
 - c. apresenta teste de tração positivo¹ (sim ou não);
2. anexar fotografias de todas as áreas acometidas;
3. tratamento em uso ou já realizado para alopecia (medicamentos utilizados com posologia e tempo de uso);
4. utiliza outros medicamentos continuamente (sim ou não). Se sim, descreva;
5. resultado de exames laboratoriais, com data: hemograma, ferritina, VDRL, TSH;
6. número da teleconsulta, se o caso já foi discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

¹Teste de tração: tracionar mechas de aproximadamente entre 50 a 60 fios de cabelo, iniciando-se próximo ao couro cabeludo, em direção distal dos fios. Deve ser realizada em diferentes áreas do couro cabeludo (região frontal, parietal direita e esquerda e occipital). O teste de tração é positivo quando há fácil remoção de 3 a 5 fios em uma única mecha ou 15 fios em 3 mechas.

Protocolo 9 – Urticária e Angioedema

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para urgência/emergência:

- episódio de angioedema e/ou urticária associados a sinais de gravidade (obstrução de via aérea, broncoespasmo e hipotensão).

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Dermatologia:

- urticária crônica (lesões recorrentes, no mínimo 2 vezes na semana, por pelo menos 6 semanas) refratária ao tratamento clínico otimizado por 4 semanas ou mais ([quadro 25](#)).

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Imunologia:

- angioedema recorrente (mais de 1 episódio), sem lesões de urticária e sem etiologia identificada;
- angioedema e/ou urticária associados a sinais de gravidade (obstrução de via aérea, broncoespasmo e hipotensão), após avaliação em serviço de urgência/emergência.

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:

1. descrição do quadro clínico:
 - a. lesões e localização;
 - b. tempo de evolução;
 - c. outros sinais e sintomas associados;
2. tratamento em uso ou já realizado para urticária (medicamentos utilizados com posologia e tempo de uso);
3. resultado de exames laboratoriais (hemograma com plaquetas, VHS/VSG e PCR), com data (se realizados);
4. número da teleconsulta, se o caso já foi discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

Protocolo 10 – Prurido

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Dermatologia:

- paciente com prurido, sem lesões cutâneas, refratário ao tratamento clínico otimizado e sem causa identificada, após investigação inicial na APS ([quadro 26](#)).

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:

1. descrição do quadro clínico:
 - a. tempo de evolução;
 - b. apresenta lesões cutâneas (sim ou não). Se sim, descreva as características clínicas e localização;
 - c. outros sinais e sintomas associados;
2. anexar fotografias de lesões de pele (se presentes);
3. resultado de exames laboratoriais, com data: hemograma, transaminases, fosfatase alcalina, bilirrubinas, GGT, TSH, creatinina, raio-x de tórax, testes rápidos para HIV, HBV e HCV (ou anti-HIV, anti-HCV e HBsAg);
4. tratamento em uso ou já realizado para prurido (medicamentos utilizados com posologia, tempo de uso e orientações);
5. número da teleconsultoria, se o caso já foi discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

Protocolo 11 – Condiloma Acuminado, Verrugas Virais e Molusco Contagioso

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Dermatologia:

- condiloma acuminado (verruga anogenital), verruga viral ou molusco contagioso:
 - em paciente imunocomprometido, refratário ao tratamento por pelo menos 1 mês ([quadro 27](#), [quadro 28](#) e [quadro 29](#)) ou com progressão rápida no número de lesões; ou
 - em paciente imunocompetente, refratário ao tratamento por pelo menos 3 meses ([quadro 27](#), [quadro 28](#) e [quadro 29](#)); ou
 - em crianças com acometimento genital, se múltiplas lesões ou associadas a sintomas (dor, sangramento, prurido); ou
 - lesões faciais:
 - verrugas virais (exceto verrugas planas); ou
 - molusco contagioso na face de adultos; ou
 - molusco contagioso periocular em adultos e crianças.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Ginecologia:

- mulheres com condiloma acuminado (verruga anogenital), com indicação de tratamento cirúrgico (lesões extensas ou muito numerosas).

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Urologia:

- homens com condiloma acuminado (verruga anogenital), com indicação de tratamento cirúrgico (lesões extensas, muito numerosas ou associadas à fimose);
- homens ou mulheres com condiloma acuminado junto ao meato ureteral ou em uretra distal.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Proctologia:

- paciente com condiloma acuminado em topografia anorretal com indicação de tratamento cirúrgico (lesões retais ou lesões perianais extensas ou muito numerosas).

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Obstetrícia em Ambulatório de Gestação de Alto Risco Tipo II (AGAR – II):

- gestante com condiloma acuminado (verruga anogenital), com indicação de tratamento cirúrgico (lesões que obstruem o canal do parto, lesões extensas ou numerosas – maiores que 20 cm²);
- gestante com condiloma acuminado no canal vaginal ou colo uterino.

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:

- descrição do quadro clínico (localização, número, tempo de evolução, extensão e toque retal, se condiloma anorretal);
- anexar fotografias das lesões (se autorizado pelo paciente);
- resultado teste rápido para HIV ou de anti-HIV, com data;
- tratamento prévio realizado (descrever medicamentos, posologia e tempo de uso);
- se mulher em idade fértil, trata-se de gestante (sim ou não);
- número da teleconsultoria, se o caso já foi discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

Atenção: embora seja possível que muitas crianças com condiloma acuminado adquiram a doença por meios não sexuais, a possibilidade de abuso sexual merece séria consideração durante a avaliação do paciente, cabendo ao profissional da APS tomar as medidas cabíveis nessas situações. É recomendado investigar outras IST em pessoas que apresentam condiloma acuminado. Oferecer testagem para sífilis e HIV no momento do diagnóstico e em 4 a 6 semanas após o diagnóstico, e para hepatite B e C no diagnóstico, além de PCR para Clamídia e Gonococo, se disponível. O uso de testes rápidos deve ser sempre preconizado.

Protocolo 12 – Rosácea

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Dermatologia:

- rosácea fimatosa (aumento de volume do tecido afetado na região do nariz, mento, glabella ou região malar);
- rosácea granulomatosa/pioderma facial (pápulas eritematosas, pústulas, cistos e trajetos fibrosos na região malar, periorbital e perioral, de surgimento súbito e na ausência de comedões);
- rosácea refratária ao tratamento clínico otimizado por 3 meses ([quadro 30](#)).

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Oftalmologia:

- rosácea ocular refratária ao tratamento clínico otimizado (higiene das margens palpebrais, lubrificante ocular e antibiótico oral - [quadro 30](#)), por 8 a 12 semanas.

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:

1. descrição do quadro clínico:
 - a. apresentação (eritema, telangiectasias, pápulas, pústulas ou fimas);
 - b. localização;
 - c. tempo de evolução;
2. anexar fotografias de todas as áreas acometidas;
3. tratamentos em uso ou já realizados para rosácea (medicações tópicas e sistêmicas, com posologia e tempo de uso);
4. número da teleconsulta, se o caso já foi discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

Protocolo 13 – Melasma

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Dermatologia:

- paciente com melasma e importante prejuízo psicológico ou funcional, refratário ao tratamento clínico otimizado por 3 meses, com boa adesão a medidas de fotoproteção ([quadro 31](#)).

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:

1. quadro clínico (tempo de evolução e características da lesão);
2. anexar fotografias de todas as áreas acometidas;
3. tratamento em uso ou já realizado para melasma (medicamentos, posologia e tempo de uso);
4. número da teleconsulta, se o caso já foi discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

Protocolo 14 – Vitiligo

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Dermatologia:

- vitiligo extenso (mais de 10% da área de superfície corporal - BSA¹);
- vitiligo rapidamente progressivo² (iniciar tratamento e encaminhar) ([quadro 32](#));
- vitiligo com resposta insatisfatória ao tratamento tópico otimizado, por 6 meses ([quadro 32](#)).

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:

1. descrição do quadro clínico:
 - a. localização;
 - b. tempo de evolução;
 - c. estimativa da área de superfície corporal acometida (BSA¹);
2. anexar fotografias de todas as áreas acometidas;
3. tratamentos já realizados para vitiligo (medicamentos, posologia e tempo de uso);
4. número da teleconsulta, se o caso já foi discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

¹Área de superfície corporal (*body surface area* - BSA): considera a palma da mão do paciente, com os dedos unidos, correspondente a 1% da superfície corporal total.

²Vitiligo rapidamente progressivo: surgimento abrupto de várias novas lesões ou aumento importante das lesões prévias ao longo de poucas semanas/meses.

Protocolo 15 – Hanseníase

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Dermatologia:

- suspeita clínica de hanseníase, com impossibilidade de realizar teste de sensibilidade ou dúvida quanto à confiabilidade do teste (por exemplo: crianças pequenas, pacientes com déficit cognitivo);
- efeitos adversos graves com as medicações do esquema padrão de poliquimioterapia (PQT);
- diagnóstico ou suspeita de reação hansênica¹ tipo 1 ou 2 – iniciar tratamento e encaminhar;
- diagnóstico de hanseníase com outras doenças associadas: nefropatia, hepatopatia ou doenças hematológicas;
- hanseníase multibacilar, sem melhora após 12 meses de tratamento;
- suspeita de recidiva²;
- suspeita de hanseníase neural, sem lesões cutâneas.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para serviço de reabilitação cirúrgica em hanseníase (Cirurgia Plástica ou Neurocirurgia):

- suspeita clínica de reação hansênica¹ com necessidade de descompressão neural cirúrgica.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Reabilitação Física:

- paciente com alteração de funcionalidade, temporária ou permanente, parcial ou total, por sequelas de hanseníase.

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:

1. descrição do quadro clínico:
 - a. descrição das lesões e localização;
 - b. número de lesões
 - c. tempo de duração;
2. anexar fotografias de todas as lesões de pele;
3. efeito adverso relacionado à poliquimioterapia (sim ou não). Se sim, descreva o quadro e a medicação suspeita;
4. suspeita de reação hansênica (sim ou não). Se sim, descreva o quadro e o tratamento iniciado, com doses e duração;
5. outras doenças associadas (nefropatia, hepatopatia, doença hematológica - sim ou não). Se sim, descreva;
6. suspeita de recidiva² (sim ou não). Se sim, descreva o tratamento realizado e sua duração;
7. número da teleconsultoria, se o caso já foi discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

¹Reações hansênicas podem surgir antes, durante ou depois do tratamento com PQT. A reação tipo 1 caracteriza-se pelo aparecimento de novas lesões dermatológicas (manchas ou placas), infiltrações, alterações de cor e edema nas lesões antigas, com ou sem espessamento e dor de nervos periféricos (neurite). A reação tipo 2, cuja manifestação clínica mais frequente é o Eritema Nodoso Hansênico (ENH), caracteriza-se pelo aparecimento de nódulos subcutâneos dolorosos, acompanhados ou não de manifestações sistêmicas como febre, dor articular, mal-estar generalizado, orquite, iridociclites, com ou sem neurite.

²Recidiva é definida como todos os casos de hanseníase tratados regularmente com esquemas oficiais padronizados e corretamente indicados, que receberam alta por cura (aqueles que saíram do registro ativo da doença no Sinan), e que voltam a apresentar novos sinais e sintomas clínicos de doença infecciosa ativa. Os casos de recidiva geralmente ocorrem em período superior a cinco anos após a cura.

Protocolo 16 – Anormalidades Cicatriciais (Queloides e Cicatriz Hipertrófica)

Queloides é a proliferação fibrosa excessiva além da área original traumatizada (envolvendo a pele adjacente). Cicatriz hipertrófica é toda a cicatrização excessiva confinada à área do trauma (bordas respeitam os limites da área lesionada).

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Dermatologia:

- queloides ou cicatriz hipertrófica¹, sem limitação funcional (de mobilidade, dor, retração ou dificuldades nas atividades da vida diária), porém com prejuízo estético importante e sofrimento psicológico associado, com indicação de infiltração intralesional de corticoide.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Cirurgia Plástica:

- cicatriz por sequela de queimadura que cause:
 - deformidade facial (alteração funcional das pálpebras, do nariz e dos lábios); ou
 - deformidade e restrição dos movimentos do pescoço; ou
 - restrição dos movimentos articulares em qualquer área;
- queloides ou cicatriz hipertrófica, que cause limitação funcional (de mobilidade, dor, retração ou dificuldades nas atividades da vida diária);
- cicatriz pós-trauma, cirurgia ou doença (geralmente grande ou múltiplas) que resulte em aparência muito ruim e sofrimento psicológico importante ou prejuízo funcional (de mobilidade, dor, retração ou dificuldades nas atividades da vida diária).

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:

1. descrição do quadro clínico:
 - a. descrição das lesões e localização;
 - b. sinais e sintomas associados;
 - c. manifestações de gravidade e prejuízo funcional;
 - d. tempo de evolução;
2. anexar fotografias de todas as lesões de pele;
3. tratamento atual ou realizado para a condição (descrever medicamentos, posologia e tempo de uso);
4. número da teleconsulta, se o caso já foi discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

¹Cicatriz considerada inestética, mas sem componente hipertrófico ou queloidiano, não tem indicação de encaminhamento. Excetuam-se os casos em que o dano físico estético resulta de atos de violência contra a mulher, como previsto na Lei Estadual nº 13.448 de 22 de abril de 2010.

Apêndices – quadros auxiliares

Quadro 1 – Tratamento clínico otimizado para acne, conforme gravidade¹.

Gravidade	Acne	Primeira escolha	Alternativa	Manutenção ²
Leve	Comedoniana	Retinoide tópico ⁴ .	Outro retinoide tópico ⁴ ; OU ácido azelaico.	Retinoide tópico ⁴ (com ou sem peróxido de benzoíla).
	Mista e papulopustulosa	Terapia tópica combinada: retinoide tópico ⁴ + antibiótico tópico ⁵ ; OU antibiótico tópico ⁵ + peróxido de benzoíla; OU retinoide tópico ⁴ + peróxido de benzoíla.	Outro retinoide tópico ⁴ + antibiótico tópico ⁵ ; OU retinoide tópico ⁴ + antibiótico tópico ⁵ + peróxido de benzoíla; OU ácido azelaico.	Retinoide tópico ⁴ (com ou sem peróxido de benzoíla).
Moderada	Mista e papulopustulosa	Terapia combinada oral e tópica: Antibiótico oral ⁶ ; E retinoide tópico ⁴ e/ou peróxido de benzoíla tópico.	Outro antibiótico oral ⁶ + outro retinoide tópico ⁴ e/ou peróxido de benzoíla; OU ácido azelaico.	Retinoide tópico ⁴ (com ou sem peróxido de benzoíla).
	Nodular		Isotretinoína oral ⁷ ; OU outro antibiótico oral ⁶ + outro retinoide tópico ⁴ e/ou peróxido de benzoíla. Se mulher: considerar terapia antiandrogênica ⁸ .	Retinoide tópico ⁴ (com ou sem peróxido de benzoíla).
Grave	Conglobata	Isotretinoína oral ⁷ (com ou sem corticoide oral); OU antibiótico oral + retinoide + peróxido de benzoíla.	Outro antibiótico oral ⁷ ; OU associar corticoide oral; OU isotretinoína oral (se não estiver em uso) ⁷ . Se mulher: considerar terapia antiandrogênica ⁸ .	Retinoide tópico ⁴ (com ou sem peróxido de benzoíla).
	Fulminans ³	Isotretinoína oral ⁷ + corticoide oral; OU antibiótico oral + corticoide oral.	-	Retinoide tópico ⁴ (com ou sem peróxido de benzoíla).

¹Tratamentos sugeridos na gestação: ácido azelaico* ou clindamicina tópicos (categoria B). Para casos moderados a graves: considerar terapia oral com azitromicina 500 mg/dia, por 3 dias consecutivos, 1x/mês, por 3 a 4 ciclos.

²Tratamento de manutenção deve ser iniciado de 3 a 6 meses após resposta satisfatória ao tratamento inicial.

³Pacientes com acne fulminans devem receber tratamento inicial na APS com corticoide oral (prednisona 0,5 a 1 mg/kg/dia), no momento do diagnóstico, enquanto aguardam consulta com o especialista. Após 2 a 4 semanas, se ainda não estiver em acompanhamento presencial com Dermatologia, pode-se considerar o início do antibiótico oral (tetraciclina 500 mg, 2x/dia ou doxiciclina 100 mg, 2x/dia) e a manutenção da prednisona. Como trata-se de uma doença grave, sugerimos acompanhar o caso por meio de teleconsultoria com dermatologia, pelo canal do TelessaúdeRS-UFRGS (0800 644 6543).

⁴Retinoides tópicos: adapaleno*, tretinoína*.

⁵Antibióticos tópicos: clindamicina 1%.

⁶Antibióticos orais: tetraciclina, doxiciclina.

⁷Não se deve usar antibiótico sistêmico (especialmente tetraciclina) concomitantemente à isotretinoína oral pelo risco de hipertensão intracraniana benigna ("pseudotumor cerebral").

⁸Contraceptivo oral combinado com progesterona com ação antiandrogênica (ciproterona*, dienogeste*, drospirenona*, clormadinona*); OU método contraceptivo associado à espironolactona 100-200 mg/dia (se função renal normal, em paciente sem histórico de hipotensão).

*Alguns dos medicamentos descritos NÃO estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso este não esteja disponível no SUS.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023), adaptado de Bologna, Schaffer e Cerroni (2017) e Zaenglein (2018).

Quadro 2 – Posologia de medicamentos para tratamento da acne na APS.

Medicação	Produto	Efeitos adversos	Aplicação
Retinóides tópicos			
Tretinoína*	0,25 mg/g - gel e creme 0,5 mg/g - creme 1 mg/g - creme	Irritação local: eritema, ressecamento, descamação, ardência e prurido.	Aplicar o equivalente ao volume de 1 ervilha. Espalhar em toda a face, à noite.
Adapaleno*	1 mg/g - gel e creme 3 mg/g - gel		
Antimicrobianos tópicos			
Peróxido de benzoíla	2,5 - 5% gel	Irritação local; pode descolorir cabelos e roupas.	1 a 2x/dia.
Ácido azelaico*	15% gel e 20% creme	Irritação local	2x/dia
Produtos tópicos combinados*			
Peróxido de benzoíla 50 mg/g + clindamicina 10 mg/g	2x/dia.		
Peróxido de benzoíla 25 mg/g + adapaleno 1 mg/g	1x/dia aplicado à noite.		
Tretinoína 0,25 mg/g + clindamicina 12 mg/g	1x/dia aplicado à noite.		
Adapaleno 1 mg/g + clindamicina 10 mg/g	1x/dia aplicado à noite.		
Antibióticos Sistêmicos¹ (orais)			
Tetraciclina 500 mg	2x/dia. Deve ser tomada longe das refeições (1 hora antes ou 2 horas depois). Está contraindicada para gestantes e crianças menores de 8 anos.		
Doxiciclina 100 mg	1 a 2x/dia. A dose varia conforme peso e grau de acometimento da acne. Deve ser tomada logo após a refeição, para evitar efeitos gastrointestinais. Está contraindicada para gestantes e crianças menores de 8 anos.		

*Alguns dos medicamentos descritos NÃO estão inclusos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

¹A duração do tratamento deve ser limitada a 3 a 4 meses e sua utilização em monoterapia não está indicada. Desde o início do seu tratamento deve estar associado com peróxido de benzoíla tópico ou retinoide tópico, visto que a associação aumenta a eficácia, reduz resistência bacteriana e facilita a descontinuidade do antibiótico oral.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023).

Quadro 3 – Suspeita clínica de melanoma.

Lesão melanocítica com:

- sinal do “patinho feio”: lesão pigmentada com padrão diferente das outras; ou
- um ou mais critérios da regra do ABCDE:
 - A. assimetria;
 - B. bordas irregulares;
 - C. cores variadas (pelo menos duas cores diferentes na lesão);
 - D. diâmetro maior que 6 mm;
 - E. evolução (alteração recente de tamanho, forma, cor, aparência).

Fonte: Geller e Swetter (2021).

Quadro 4 – Paciente com alto risco para melanoma.

Paciente com três ou mais dos critérios abaixo ou critérios E e F juntos:

- A. fototipo I ou II ([quadro 5](#));
- B. efélides;
- C. história de queimadura solar com formação de bolhas antes dos 20 anos;
- D. história de bronzeamento artificial antes dos 35 anos;
- E. múltiplos nevos melanocíticos (> 50) ou pelo menos um nevo atípico (determinado por exame anatomopatológico);
- F. um familiar em primeiro grau ou dois ou mais familiares (independentemente do grau) com história de melanoma.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023), adaptado de Boniol *et al.* (2012), Wu (2022), Geller e Swetter (2021).

Quadro 5 – Classificação de fototipos cutâneos (FTC).

FTC	Cor básica da pele	Resposta à exposição solar
I	Branco-pálida	Não se bronzeia, queima facilmente.
II	Branca	Bronzeia-se com dificuldade, queima facilmente.
III	Branca	Bronzeia-se facilmente, mas pode queimar-se inicialmente.
IV	Castanho-clara/oliva	Bronzeia-se facilmente, queima-se dificilmente.
V	Castanha	Bronzeia-se facilmente, geralmente não se queima.
VI	Negra	Escurece mais, não se queima.

Fonte: Goldsmith *et al.* (2012).

Quadro 6 – Indicações de investigação de linfonodo sentinela após o diagnóstico histopatológico de melanoma.

- Ausência de sinais clínicos de metástases regionais ou à distância, associado a qualquer um dos critérios abaixo:
 - índice de Breslow > 0,8 mm; OU
 - presença de ulceração; OU
 - presença de invasão linfovascular.

*A presença de metástases a distância exclui a necessidade de investigação de linfonodo sentinela.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023), adaptado de Brasil (2022).

Quadro 7 – Especialidades indicadas para tratamento de lesões de pele com necessidade de tratamento cirúrgico.

	Lesões benignas (lipoma, cisto epidérmico/"sebáceo", nevos)	Lesões com suspeita de malignidade (sem AP)	Lesões malignas (com AP)
Dermatologia	Até 2 cm em tronco e membros ou até 1 cm em face e pescoço, quando não abordadas na APS ou em agenda de cirurgia ambulatorial.	Até 2 cm no tronco e membros ou até 1 cm na face e pescoço.	Até 2 cm no tronco e membros ou até 1 cm na face e pescoço.
Cirurgia Ambulatorial	Até 5 cm.	Especialidade não indicada.	Especialidade não indicada.
Cirurgia Plástica	Localizadas em áreas difíceis ou especiais (face, orelhas, articulações), quando não abordadas por dermatologista* ou cirurgia ambulatorial.	Localizadas em áreas difíceis ou especiais (face, orelhas, articulações) ou lesões complexas, extensas ou profundas, com alta probabilidade de necessitar de retalho ou enxerto, quando não abordadas em agenda de Oncologia Cirurgia Pele.	Localizadas em áreas difíceis ou especiais (face, orelhas, articulações) ou lesões complexas, extensas ou profundas, com alta probabilidade de necessitar de retalho ou enxerto, quando não abordadas em agenda de Oncologia Cirurgia Pele.
Cirurgia Geral	> 5 cm.	Especialidade não indicada.	Especialidade não indicada.
Oncologia Cirurgia Pele	Especialidade não indicada.	Maiores do que 2 cm em tronco e membros, maiores que 1 cm em face e pescoço ou localizadas em áreas difíceis ou especiais (face, orelhas, articulações).	Maiores do que 2 cm em tronco e membros, maiores que 1 cm em face e pescoço ou localizadas em áreas difíceis ou especiais (face, orelhas, articulações).
Estomatologia	Lesões labiais ou em cavidade bucal, pequenas ou superficiais, com necessidade de biópsia incisional diagnóstica antes da definição terapêutica.	Especialidade não indicada.	Especialidade não indicada.
Oftalmologia	Lesões palpebrais benignas.	Lesões palpebrais suspeitas de câncer de pele não melanoma, quando não abordadas em agenda de Oncologia Cirurgia Pele. Se suspeita de melanoma, encaminhar para referência regional de Oncologia Cirurgia Pele.	Câncer de pele não melanoma localizado na pálpebra, quando não abordadas em agenda de Oncologia Cirurgia Pele. Se melanoma, encaminhar para referência regional de Oncologia Cirurgia Pele.

*Nevos intradérmicos nessas localizações, cistos epidérmicos pequenos em face e articulações.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023).

Quadro 8 – Tratamento clínico para ceratoses actínicas com 5-fluoruracila* - 5% creme.

- Aplicar na lesão ou na área com lesões, 1 ou 2x/dia, por 2 a 4 semanas.
- Se o tratamento for efetivo, irá ocasionar eritema e inflamação após 2 a 4 semanas, que irão resolver espontaneamente após sua descontinuação. Orientar que não é necessário suspender o tratamento, caso esses efeitos ocorram.
- Orientar uso regular de protetor solar FPS 30 (ou maior) e reaplicação a cada 2 horas, se exposição solar direta. Orientar o uso de chapéus e bonés.
- Reavaliar um mês após o término do tratamento, ou antes, se houver dúvidas quanto à evolução.

*O medicamento descrito NÃO está incluso na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

Fonte: Berman (2022).

Quadro 9 – Índice de qualidade de vida dermatológico (DLQI).

Este questionário visa medir o quanto o problema de pele que você tem afetou sua vida durante a semana que passou. Escolha apenas uma resposta para cada pergunta.

1. O quanto sua pele foi afetada durante a semana que passou por causa de coceira, inflamação, dor ou queimação?	Realmente muito (3)	Bastante (2)	Um pouco (1)	Nada (0)
2. Quanto constrangimento ou outro tipo de limitação foi causado por sua pele durante a semana que passou?	Realmente muito (3)	Bastante (2)	Um pouco (1)	Nada (0)
3. O quanto sua pele interferiu nas suas atividades de compras ou passeios, em casa ou locais públicos, durante a semana que passou?	Realmente muito (3)	Bastante (2)	Um pouco (1)	Nada / Sem relevância (0)
4. Até que ponto sua pele interferiu na semana que passou, com relação às roupas que você normalmente usa?	Realmente muito (3)	Bastante (2)	Um pouco (1)	Nada / Sem relevância (0)
5. O quanto sua pele afetou qualquer uma das suas atividades sociais ou de lazer na semana que passou?	Realmente muito (3)	Bastante (2)	Um pouco (1)	Nada / Sem relevância (0)
6. Quão difícil foi para você praticar esportes durante a semana que passou?	Realmente muito (3)	Bastante (2)	Um pouco (1)	Nada/ Sem relevância (0)
7. Sua pele impediu que você fosse trabalhar ou estudar durante a semana que passou?	Sim (3)	-	-	Não / Sem relevância (0)
Em caso negativo, sua pele já foi problema para você no trabalho ou na vida escolar?	-	Bastante (2)	Um pouco (1)	Nada (0)
8. Quão problemática se tornou sua relação com o(a) parceiro(a), amigos próximos ou parentes, por causa de sua pele?	Realmente muito (3)	Bastante (2)	Um pouco (1)	Nada / Sem relevância (0)
9. Até que ponto sua pele criou dificuldades na sua vida sexual na semana que passou?	Realmente muito (3)	Bastante (2)	Um pouco (1)	Nada / Sem relevância (0)
10. Até que ponto seu tratamento dermatológico criou problemas para você na semana que passou?	Realmente muito (3)	Bastante (2)	Um pouco (1)	Nada / Sem relevância (0)

O DLQI é um questionário validado para uso no Brasil, que avalia o impacto de doenças dermatológicas na qualidade de vida dos pacientes em relação a atividades de vida diária. O escore total é calculado somando-se a pontuação de cada item. Ele varia de 0 a 30, sendo melhor a qualidade de vida, quanto menor o escore. Um escore maior que 10 indica prejuízo funcional grave.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023), adaptado de Martins, Arruda e Mugnaini (2004).

Quadro 10 – Índice de qualidade de vida dermatológico infantil (CDLQI).

Este questionário visa medir o quanto o problema de pele que você tem afetou sua vida durante a semana que passou. Escolha apenas uma resposta para cada pergunta.				
1. Sua pele tem apresentado coceira, sensibilidade ou dor?	Muitíssimo (3)	Muito (2)	Pouco (1)	Não (0)
2. Você sentiu-se constrangido, inibido, chateado ou triste por causa de sua pele?	Muitíssimo (3)	Muito (2)	Pouco (1)	Não (0)
3. Sua pele tem afetado suas amizades?	Muitíssimo (3)	Muito (2)	Pouco (1)	Não (0)
4. Você mudou a sua maneira de se vestir por causa da sua pele?	Muitíssimo (3)	Muito (2)	Pouco (1)	Não (0)
5. Sua pele tem atrapalhado as suas atividades de lazer em geral?	Muitíssimo (3)	Muito (2)	Pouco (1)	Não (0)
6. Você evitou nadar ou praticar outros esportes por causa dos seus problemas de pele?	Muitíssimo (3)	Muito (2)	Pouco (1)	Não (0)
7. Se período escolar: o quanto seu problema de pele interferiu em suas atividades escolares? Se período de férias: quanto seu problema de pele interferiu no aproveitamento de suas férias?	Muitíssimo (3)	Muito (2)	Pouco (1)	Não (0)
8. Você teve problemas com pessoas dizendo nomes, caçoando, intimidando, fazendo perguntas ou evitando você?	Muitíssimo (3)	Muito (2)	Pouco (1)	Não (0)
9. Seu sono foi afetado por causa de seu problema de pele?	Muitíssimo (3)	Muito (2)	Pouco (1)	Não (0)
10. Seu tratamento dermatológico foi problemático?	Muitíssimo (3)	Muito (2)	Pouco (1)	Não (0)
O CDLQI é um questionário validado para uso no Brasil, que avalia o impacto de doenças dermatológicas na qualidade de vida dos pacientes em relação a atividades de vida diária. O escore total é calculado somando-se a pontuação de cada item. Ele varia de 0 a 30, sendo melhor a qualidade de vida, quanto menor o escore. Um escore maior que 10 indica prejuízo funcional grave.				

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023), adaptado de Prati *et al.* (2010).

Quadro 11 – Tratamento clínico otimizado para dermatite atópica.

- Manutenção da barreira cutânea: orientar banhos rápidos (5 a 10 minutos), com água morna, utilizar sabonetes pouco abrasivos (preferencialmente líquidos ou *syndets*) e sem fragrâncias, em pequena quantidade e não utilizar esponjas.
- Evitar fatores de exacerbação: perfumes, cremes perfumados, sabão em pó perfumado, amaciantes de roupas e roupas sintéticas em contato direto com a pele.
- Avaliar a necessidade de manejo de fatores emocionais associados à exacerbação, como estresse e ansiedade.
- Orientar uso regular (no mínimo 2x/dia) de hidratantes sem fragrâncias*, comercialmente disponíveis (hidratantes em creme sem fragrância ou vaselina pomada) ou sob manipulação (por exemplo: óleo de semente de girassol 10% + glicerina 2% em creme sem fragrância 250 g).
- Corticoides tópicos (dexametasona, mometasona*): nas áreas de eczema, 1 ou 2x/dia, por 2 a 4 semanas. Considerar potência ([quadro 12](#)) conforme idade do paciente e localização das lesões. Avaliar efeitos adversos.
- Anti-histamínicos sedativos para controle do prurido (por exemplo, dexclorfeniramina, hidroxizina*).
- Tratar infecções cutâneas associadas: bacterianas, fúngicas e virais.
- Sempre avaliar a adesão do paciente antes de considerar falha terapêutica.

*Alguns dos medicamentos descritos NÃO estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023), adaptado de Bologna, Schaffer e Cerroni (2017).

Quadro 12 – Potência dos corticosteroides tópicos.

Potência	Fármaco	Formulação
Muito alta	Propionato de clobetasol 0,05%	Pomada*, creme, solução capilar, xampu*.
	Fludrocortida 4 mcg/cm ²	Fita oclusiva*.
	Propionato de halobetasol 0,05%	Creme*.
Alta	Dipropionato de betametasona 0,05%	Pomada*.
	Desoximetasona 0,25%	Pomada*.
Média	Dipropionato de betametasona 0,05%	Creme*, loção*.
	Valerato de betametasona 0,1%	Pomada*, creme*, loção*, solução capilar*.
	Furoato de mometasona 0,1%	Pomada*, creme*.
	Aceponato de metilprednisolona 0,1%	Creme*, loção*, solução capilar*.
	Propionato de fluticasona 0,05%	Creme*.
	Fludrocortida 0,0125%	Pomada*, creme*, loção*.
	Triancinolona acetona 0,1%	Pomada orobase*.
Baixa	Desonida 0,05%	Pomada*, creme*, loção*, gel*.
	Hidrocortisona 1%	Pomada*, creme.
	Dexametasona 0,1%	Creme.

*Alguns dos medicamentos ou formulações descritas NÃO estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023), adaptado de Bologna, Schaffer e Cerroni (2017), WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (2021), Goldstein e Goldstein (2022b) e Stacey e McEleney (2021).

Quadro 13 – Tratamento clínico otimizado conforme o tipo de eczema.

Eczema seborreico

- **Couro cabeludo:** cetozonazol 2% xampu, lavar os cabelos e deixar agir por 3 a 5 minutos, 2 a 5x/semana, por 2 a 4 semanas (fase de tratamento). Em casos mais graves, associar corticoide tópico (ex: dipropionato de betametasona 0,05% solução* ou propionato de clobetasol 0,05% solução, 1 a 2x/dia por 2 a 4 semanas. Após a melhora dos sintomas, o cetozonazol 2% xampu pode ser mantido 1 a 2x/semana, nas áreas que costumam apresentar lesões para reduzir a chance de recidivas (fase de manutenção).
- **Face e corpo:** cetozonazol 2% ou miconazol 2% creme, 2x/dia, por até 4 semanas e/ou corticoide tópico de baixa potência ([quadro 12](#)) na face ou áreas intertriginosas do corpo ou corticoide tópico de média potência ([quadro 12](#)) nas demais áreas, 1 a 2x/dia, até melhora (pelo menor tempo possível). Após a resolução dos sintomas, o xampu de cetozonazol 2% pode ser utilizado 1 a 2x/semana nas áreas normalmente acometidas para reduzir a chance de recidivas.

Dermatite de contato

Identificar e afastar o fator precipitante e prescrever corticoide tópico¹ ([quadro 12](#)) 2x/dia, por 2 a 4 semanas.

Eczema disidrótico

Corticoide tópico, creme ou pomada, de alta ou muito alta potência ([quadro 12](#), ex: propionato de clobetasol 0,05% ou dipropionato de betametasona 0,05%*), 2x/dia, por 2 a 4 semanas.

Utilizar sabonetes suaves, aplicar hidratantes (ou vaselina) após lavar as mãos, fazer uso de luvas para contato com água, produtos irritantes ou atividades que ocasionam fricção local (p. ex. jardinagem), fazer uso de luvas para o frio.

Eczema de estase

O tratamento do quadro agudo (eritema, exsudação, prurido) inclui:

- higiene diária com sabonetes neutros (sem perfume);
- corticoides tópicos de média ou alta potência em pomada ([quadro 12](#), ex.: furoato de mometasona 0,1%* pomada ou valerato de betametasona 0,1%* pomada), 1 a 2x/dia, por 1 a 2 semanas.

Em caso de crostas ou exsudação, está indicado:

- aplicação de compressas úmidas: umedecer pano limpo, algodão ou gazes de algodão em soro fisiológico, água limpa ou permanganato de potássio (este último diluir 100 mg – equivalente a 1 comprimido ou 1 sachê – em 1 a 4 L de água, até ficar cor rosa claro). Aplicar nas áreas acometidas e cobrir com ataduras de algodão secas. A compressa deve permanecer em contato com a pele por 2 a 3 horas e podem ser utilizadas de 2 a 3x/dia. Logo após a remoção, aplicar hidratantes (p.ex.: vaselina pomada*, óleo mineral) para manter a umidade local.

Para reduzir a chance de um novo episódio, é imprescindível manter a pele hidratada e tratar a insuficiência venosa crônica de base com orientações para o paciente:

- perda de peso: se sobrepeso ou obesidade;
- elevação dos membros inferiores acima do nível do coração, 3x/dia, por 30 minutos;
- atividade física: caminhadas e exercícios de dorsiflexão dos pés sempre que estiver sentado;
- uso diário de meias ou ataduras elásticas compressivas de média compressão (20 a 30 mmHg). Veja mais sobre meias elásticas [aqui](#);
- uso de hidratantes/emolientes após o banho, dando preferência para produtos oleosos e sem fragrâncias (ex: vaselina ou óleo mineral).

*Alguns dos medicamentos descritos NÃO estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

¹Considerar potência do corticoide tópico conforme a idade do paciente e localização das lesões.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023).

Quadro 14 – Micoses subcutâneas mais comuns.

- Paracoccidioidomicose.
- Esporotricose.
- Cromoblastomicose.
- Micetoma.
- Lobomicose.
- Histoplasmosse.

Fonte: Bolognia, Schaffer e Cerroni (2017).

Quadro 15 – Tratamento clínico otimizado para candidíase mucocutânea.**Candidíase Orofaringea**

- Adultos¹
 - Nistatina suspensão 100.000 UI/mL: bochechar e engolir 4 a 6 mL, 4x/dia, por 7 a 14 dias.
 - Nitrato de miconazol gel 2%: 1,25 mL, 4x/dia, por 7 a 14 dias.
 - Na ausência de resposta ou em casos extensos ou recorrentes, utilizar fluconazol 150 mg/dia, por 7 a 14 dias.
- Crianças
 - Nistatina suspensão 100.000 UI/mL: bochechar e engolir 4 a 6 mL, 4x/dia, por 7 a 14 dias.
 - Nitrato de miconazol gel 2%: 1,25 mL, 4x/dia, por 7 a 14 dias.
 - Na ausência de resposta, utilizar fluconazol 6 mg/kg/dose no primeiro dia e, após, 3 mg/kg/dia por 7 a 14 dias (dose máxima de 200 mg/dia).
- Bebês²
 - Nistatina suspensão 100.000 UI/mL: 2 mL (1 mL em cada bochecha) 4x/dia por 7 a 14 dias.
 - Nitrato de miconazol gel 2%: 1,25 mL, 4x/dia, por 7 a 14 dias.
 - Na ausência de resposta, utilizar fluconazol 6 mg/kg no primeiro dia e após 3 mg/kg/dia por 7 a 14 dias (dose máxima de 200 mg/dia).

Intertrigo por Candida

- Avaliar e tratar fatores predisponentes como: DM2, hiperidrose, incontinência urinária, uso de corticoides tópicos e uso de medicamentos imunossupressores.
- Quadros leves a moderados: tratamento tópico com miconazol 2% creme (outras opções são: nistatina, ciclopirox* ou outros azólicos) - aplicar na lesão 2x/dia, até melhora clínica completa (cerca de 2 a 4 semanas).
- Se falha terapêutica ou apresentação extensa: tratamento oral com fluconazol ou itraconazol³.
 - Adultos: fluconazol 150 mg/semana ou itraconazol 200 mg, 2x/dia, por 2 a 6 semanas.
 - Crianças: fluconazol 6 mg/kg/dia no primeiro dia, após 3 mg/kg/dia por 2 a 6 semanas ou itraconazol 5 a 10 mg/kg/dia dividido em 2 doses, por 2 a 6 semanas.

*O medicamento descrito NÃO está incluso na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

¹Se estomatite por dentadura, além de tratar o paciente, tratar também a prótese (remover a dentadura antes de ir para a cama, escová-la vigorosamente e depois imergir em solução de gluconato de clorexidina ou em água sanitária (10 gotas em um copo cheio de água)). A prótese deve ser revisada para verificar se está adequada.

²Em bebês, para evitar a recontaminação, é imprescindível que objetos levados à boca, como brinquedos e bicos artificiais, sejam devidamente desinfetados, sendo fervidos após cada uso, por 1 minuto. Caso a criança esteja em aleitamento materno, a mãe deverá ser avaliada quanto a presença de sinais e sintomas sugestivos de infecção por cândida nos mamilos.

³Atentar para possíveis interações medicamentosas com itraconazol. Contraindicado uso concomitante com sinvastatina e em pacientes com insuficiência cardíaca (IC). Usar com cautela em pacientes com fatores de risco para IC.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023).

Quadro 16 – Tratamento clínico otimizado para dermatofitoses (*Tineas*)¹.

Tinea corporis ou tinea cruris - Tratamento inicial: antifúngico tópico (ex: miconazol 2% creme), 2x/dia, por 1 a 3 semanas ou até resolução clínica. - Se refratário ao tratamento ou lesões extensas: antifúngico sistêmico. - Adultos: terbinafina* 250 mg, 1x/dia, por 1 a 2 semanas; ou itraconazol² 100 mg, 2 cápsulas, 1x/dia, por 1 semana. - Crianças: terbinafina* (conforme peso - 10 a 20 kg: 62,5 mg; 20 a 40 kg: 125 mg; > 40 kg: 250 mg – 1x/dia por 1 a 2 semanas) ou itraconazol² 3 a 5 mg/kg, 1x/dia, por 1 semana (dose máxima de 200 mg/dia).
Tinea pedis e mannum - Tratamento inicial: antifúngico tópico (ex: miconazol 2% creme), 2x/dia, por 1-4 semanas ou até resolução clínica. - Se refratário ao tratamento tópico: antifúngico sistêmico. - adultos: terbinafina* 250 mg 1x/dia por 2 semanas; ou itraconazol¹ 100 mg, 2 cápsulas, 2x/dia por 1 semana; ou fluconazol 150 a 200 mg, 1x/semana, por 2 a 6 semanas.
Tinea capitis - Tratamento é sempre com antifúngico oral. Primeira escolha: griseofulvina* ou terbinafina*. Fluconazol e itraconazol tem indicação limitada pois possuem menor eficácia. - Griseofulvina micronizada* (sob manipulação), em adultos e crianças com mais de 1 mês de idade: 20 a 25 mg/kg/dia (dose máxima diária de 1.000 mg): 1x/dia, por 6 a 12 semanas; - Terbinafina*, 1x/dia, por 4 a 6 semanas: - adultos: 250 mg; - crianças > 4 anos (conforme peso - 10 a 20 kg: 62,5 mg; 20 a 40 kg: 125 mg; > 40 kg: 250 mg).

*Alguns dos medicamentos descritos NÃO estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

¹Cetoconazol sistêmico deve ser evitado para tratamento de dermatofitoses, pois o perfil risco-benefício é desfavorável em comparação com as outras opções disponíveis.

²Atentar para possíveis interações medicamentosas com itraconazol. Contraindicado uso concomitante com sinvastatina em pacientes com insuficiência cardíaca (IC). Usar com cautela em pacientes com fatores de risco para IC.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023).

Quadro 17 – Tratamento clínico otimizado para pitíriase versicolor¹.

Tratamento tópico (primeira escolha): - antifúngicos azólicos tópicos (cremes, loções, sprays) – por exemplo: miconazol, cetoconazol, clotrimazol*, oxiconazol*: aplicar 1 a 2x/dia, por 1 a 4 semanas; ou - cetoconazol 2% xampu: deixar em contato com a pele por 5 a 10 minutos, 1x/dia, por 1 a 4 semanas. Tratamento oral (para casos extensos, recorrentes ou refratários): - fluconazol 300 mg, 1x/semana, por 2 a 4 semanas; ou - itraconazol 200 mg, 1x/dia, por 5 a 7 dias. Considerar tratamento profilático para casos recorrentes: - cetoconazol 2% xampu: aplicar em todo o corpo, manter por 10 minutos, 1x/mês (principalmente, em meses quentes). Orientar o paciente que as áreas de hipopigmentação podem permanecer, após o tratamento (a repigmentação será gradual, ao longo dos meses).
--

*Alguns dos medicamentos descritos NÃO estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

¹Cetoconazol sistêmico deve ser evitado para tratamento de pitíriase versicolor, pois o perfil risco-benefício é desfavorável, em comparação com as outras opções disponíveis.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023), adaptado de Goldstein e Goldstein (2022a).

Quadro 18 – Tratamento clínico otimizado para onicomicose.**Onicomicose nas mãos causada por:**

- Cândida: normalmente associada à paroníquia crônica, onicolise e coloração amarelada. Mais comum em pessoas que trabalham em contato frequente com água.
- Tratamento: itraconazol¹ 100 mg, 2 cápsulas, 2x/dia, por 1 semana no mês (pulso)² por 2 meses OU itraconazol 100 mg, 2 cápsulas, 1x/dia³, por 6 semanas.
- Orientar uso de luvas para atividades em contato com água.
- Dermatofito: normalmente quando associada à onicomicose dos pés.
- Tratamento: terbinafina⁴ 250 mg, 1 comprimido, 1x/dia, por 6 semanas.
 - Alternativa (segunda linha):
 - itraconazol¹, 100 mg, 2 cápsulas, 2x/dia, por 1 semana no mês. Realizar esquema (terapia em pulso²) por 2 meses; OU
 - itraconazol, 100 mg, 2 cápsulas, 1x/dia³, por 6 semanas.

Onicomicose nos pés:

- Leve a moderada (acometimento distal/lateral < 50% da unha e sem acometer a matriz/lúnula). Tratamento pode ser tópico OU sistêmico.
- Tratamento tópico:
 - amorolfina* 5% esmalte (disponível comercialmente): 1x/semana, por 9 a 12 meses. Retirar o produto da aplicação prévia com álcool antes de cada nova aplicação; ou
 - ciclopirox* 8% esmalte (disponível comercialmente ou sob manipulação): 1x/dia até melhora completa da unha, ou por até 12 meses. Remover o produto 1x/semana com álcool; ou
- tratamento sistêmico com terbinafina⁴, 250 mg, 1 comprimido ao dia, por 3 meses.
 - Alternativa (segunda linha):
 - itraconazol¹ 100 mg, 2 cápsulas, 2x/dia, por 1 semana no mês (pulso)², por 3 meses; OU
 - itraconazol 100 mg, 2 cápsulas, 1x/dia³, por 12 semanas.
- Grave (acometimento distal/lateral > 50% da unha, acometimento da matriz/lúnula, onicomicose subungueal proximal ou onicomicose distrófica total). Tratamento sistêmico.
- Terbinafina⁴, 250 mg, 1 comprimido/dia por 3 meses.
 - Alternativa (segunda linha):
 - itraconazol¹, 100 mg, 2 cápsulas, 2x/dia, por 1 semana no mês (pulso)², por 3 meses; OU
 - itraconazol, 100 mg, 2 cápsulas, 1x/dia³, por 12 semanas.

*Alguns dos medicamentos descritos NÃO estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

¹Atentar para possíveis contraindicações: uso concomitante de sinvastatina e em paciente com insuficiência cardíaca (IC). Uso cauteloso em pacientes com fatores de risco para IC.

²A terapia em pulso com itraconazol em pacientes sem hepatopatia conhecida, história prévia de hepatite medicamentosa ou uso concomitante de outras drogas hepatotóxicas não requer avaliação da função hepática prévia.

³O uso diário de itraconazol por mais de 3 a 4 semanas requer avaliação de transaminases antes do início do tratamento e a cada 4 a 6 semanas, durante seu uso.

⁴Solicitar transaminases antes do início do tratamento, se houver perspectiva de uso por mais de 3 a 4 semanas. Realizar novo controle de AST/TGO e ALT/TGP em 4 a 6 semanas, apenas para pacientes com doença hepática conhecida, abuso de álcool, história prévia de hepatite medicamentosa ou se surgimento de náuseas, vômitos, icterícia, colúria, acolia durante o tratamento. Nos demais casos não é necessário.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023).

Quadro 19 – Características da psoríase eritrodérmica e psoríase pustulosa.

Psoríase eritrodérmica: eritema e descamação em praticamente toda a extensão do tegumento (> 75% da superfície corporal). Há risco de complicações secundárias à perda da barreira cutânea, como: infecção, sepse, alteração hidroeletrólítica. Algumas vezes é necessária a internação hospitalar.

Psoríase pustulosa: eritema, descamação e pústulas generalizadas. Sintomas sistêmicos como febre, mal estar e diarreia são comuns. Fatores desencadeantes incluem: gestação, retirada de corticoide sistêmico, infecções, hipocalcemia.

Fonte: Hawkes e Duffin (2022), Kalb (2022).

Quadro 20 – Tratamento tópico otimizado para psoríase em adultos, conforme região acometida.

Orientações gerais:

- Uso de emolientes: todos os pacientes devem utilizar hidratantes nas lesões 1x/dia (por exemplo, ureia a 5% a -20% ou lactato e amônia a 10%). Deve-se aplicar nas lesões 1x/dia, para restabelecer a barreira cutânea.
- Importante reforçar com o paciente que ainda não existe cura permanente para a psoríase, tratando-se de uma doença normalmente de curso crônico, cujo objetivo do tratamento é controlar os episódios agudos e manter a remissão. A avaliação da resposta ao tratamento não deve ser realizada por meio de parâmetros exclusivamente objetivos. A satisfação e a opinião do paciente devem ser consideradas.
- Os efeitos adversos (atrofia, telangiectasias, estrias) devem ser avaliados continuamente.

Face, região genital, mamas ou áreas intertriginosas:

- 1ª escolha: (corticoide de baixa potência - [quadro 12](#)): dexametasona 0,1% creme. Aplicar nas lesões, 1 a 2x/dia, por 2 a 4 semanas. Evitar uso por período mais prolongado devido aos possíveis efeitos adversos (atrofia, telangiectasias).
- 2ª escolha: calcipotriol 0,005% pomada (evitar o uso na face): aplicar 1 a 2x/dia, por até 4 meses. Irritação local é um efeito adverso frequente.
- Alternativa: tacrolimo* 0,1% pomada ou pimecrolimo* 1% creme. Aplicar nas lesões 2x/dia, por até 8 semanas.

Couro cabeludo:

- Propionato de clobetasol 0,05% solução capilar: aplicar nas lesões do couro cabeludo 1 a 2x/dia, por 2 a 4 semanas. Após esse período, manter 2x/semana para evitar recidivas.
- LCD* 10% xampu (sob manipulação): lavar o couro cabeludo e deixar agir por 5 a 10 minutos, antes de enxaguar. Utilizar todos os dias até melhora, após manter 1 a 2x/semana para evitar recidivas; OU
- ácido salicílico 5% em pomada (disponível comercialmente ou sob manipulação): aplicar no couro cabeludo 2 horas antes do banho ou antes de dormir. Utilizar todas as noites, até melhora das escamas.

Lesões corporais:

- 1ª escolha: (corticoides tópicos de alta potência - [quadro 12](#)): propionato de clobetasol 0,05% creme ou pomada*. Aplicar nas lesões, 2x/dia, por 2 a 4 semanas. Após esse período, manter o uso apenas nos sábados e domingos, enquanto houver lesões (máximo 12 semanas) OU
- 2ª escolha: calcipotriol 0,005% pomada (evitar o uso na face): aplicar 1 a 2x/dia, por até 4 meses. Irritação local é um efeito adverso frequente.

*Alguns dos medicamentos ou formulações descritas NÃO estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023).

Quadro 21 – Tratamento tópico otimizado para psoríase em crianças.

Face, região genital, mamas ou áreas intertriginosas 1ª escolha: tacrolimo* 0,03% pomada ou pimecrolimo* 1% creme. Aplicar nas lesões 2x/dia, por até 8 semanas. 2ª escolha: (corticoide de baixa potência - quadro 12): dexametasona 0,1% creme. Aplicar nas lesões, 1 a 2x/dia, por até 2 semanas. Evitar uso por período mais prolongado devido aos possíveis efeitos adversos (como atrofia, teleangiectasias, estrias).
Couro cabeludo Dipropionato de betametasona* 0,05% solução capilar (> 4 anos): aplicar nas lesões do couro cabeludo 1 a 2x/dia, por 2 a 4 semanas.
Lesões corporais 1ª escolha: corticoides tópicos de média a alta potência (quadro 12): furoato de mometasona* 0,1%, creme ou pomada. Aplicar nas lesões, 2x/dia, por 2 a 4 semanas. Após esse período, manter o uso apenas nos sábados e domingos, enquanto houver lesões (máximo 12 semanas). 2ª escolha: calcipotriol 0,005% pomada (> 2 anos, evitar o uso na face). Aplicar 1 a 2x/dia, por até 4 meses. Irritação local é um efeito adverso frequente.

*Alguns dos medicamentos ou formulações descritas NÃO estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023), adaptado de Brasil (2019), Menter *et al.* (2020), Paller e Lund (2022) e Palma (2020).

Quadro 22 – Critérios de classificação de artrite psoriásica.

Critérios CASPAR – *Classification Criteria for Psoriatic Arthritis*

Doença inflamatória articular estabelecida e pontuação igual ou maior do que 3 pontos nos seguintes critérios:	
Psoríase - psoríase cutânea atual; ou - história de psoríase; ou - história familiar de psoríase.	2 pontos 1 ponto 1 ponto
Dactilite (“dedos em salsicha”) atual ou passado.	1 ponto
Evidência radiográfica (mãos/pés) de neoformação óssea justa-articular.	1 ponto
Fator reumatoide negativo.	1 ponto
Distrofia ungueal (onicólise, pitting, hiperkeratoses).	1 ponto

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023), adaptado de Sampaio-Barros *et al.* (2007).

Quadro 23 – Suspeita de artrite psoriásica.

Pessoa com história pessoal ou familiar de psoríase associado a pelo menos um dos seguintes critérios: 1) artrite periférica, especialmente oligoarticular e envolvendo articulações interfalangeanas distais; 2) dactilite (“dedos em salsicha”); 3) entesite/tenossinovite; 4) dor na coluna de caráter inflamatório.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023), adaptado de Olivieri *et al.* (2008).

Quadro 24 – Características e manejo das alopecias e queda de cabelo.**Alopecia cicatricial:**

- placas de alopecia com ausência de óstios foliculares;
- provocada por doenças inflamatórias que levam a perda permanente dos pelos;
- podem acometer couro cabeludo e barba;
- causas: lúpus eritematoso discoide, alopecia cicatricial centrífuga, líquen plano pilar, por exemplo;
- manejo: todos os casos devem ser encaminhados para atendimento presencial com o Dermatologista.

Alopecia areata:

- placas de alopecia, geralmente, em áreas redondas ou ovais, sem qualquer indício de inflamação da pele;
- os óstios foliculares estão preservados e os pelos podem voltar a crescer;
- mais comum no couro cabeludo, mas pode acometer barba, cílios e outras áreas do corpo.
- manejo:
 - solicitar TSH e teste rápido para sífilis (ou VDRL);
 - se menos de 30% do couro cabeludo acometido, é possível iniciar o manejo na APS. Se não há desconforto estético importante e não há progressão do quadro, considerar conduta expectante (pode ocorrer repilação espontânea). Se optar pelo tratamento ativo, orientar o uso de dipropionato de betametasona* 0,05% ou propionato de clobetasol 0,05% (pomada*, creme, loção* ou solução), 1x/dia, por 90 dias, na área de alopecia e 1 cm da região perilesional. Se houver melhora, reduzir a frequência de aplicação até a retirada, entre 3 e 6 meses;
 - para crianças, pode-se optar pelo esquema alternativo com propionato de clobetasol 0,05% creme, 2x/dia, por 6 semanas. Parar por 6 semanas e, então, repetir a aplicação por mais 6 semanas. Reavaliar ao final de 24 semanas. Não há idade mínima estabelecida para o tratamento com corticoide tópico, mas a alopecia areata é rara em crianças menores de 3 anos.
 - para área de barba ou sobrancelha, sugere-se optar por furoato de mometasona* 0,1% creme, 2x/dia, por 6 semanas. Atentar para os possíveis efeitos adversos, como atrofia e foliculite.

Eflúvio telógeno:

- aumento transitório da queda de cabelo relacionado a fatores de estresse físico ou emocional;
- normalmente ocorre de 3 a 4 meses após a exposição/gatilho;
- com a correção da causa, o quadro cessa e o crescimento retorna em cerca de 6 a 12 meses;
- os principais fatores desencadeantes são:
 - pós-parto, suspensão do anticoncepcional oral, cirurgias, dieta restritiva, perda ponderal rápida e estresse psicológico;
 - doenças do couro cabeludo (eczema seborreico, *tinea capitis*);
 - hipotireoidismo ou hipertireoidismo, doenças graves (neoplasia maligna, infecções crônicas);
 - COVID-19;
 - medicamentos (captopril, anticoagulantes, lítio, inibidor seletivo de recaptção da serotonina, quimioterápicos, esteroides anabolizantes, vitaminas do complexo B, suspensão/troca de contraceptivo hormonal, entre outros);
- manejo: anamnese e exame físico para identificar e, se possível, remover a causa. De acordo com a avaliação clínica, outros exames complementares podem ser solicitados na suspeita de causas secundárias associadas, como hemograma, ferritina e TSH. Para valores de ferritina abaixo de 40 ng/dL, parece haver benefício na reposição de ferro (mesmo na ausência de anemia).

Alopécia androgenética:

- envolve fatores genéticos, conhecida como calvície;
- caracterizada por afinamento progressivo dos fios terminais;
- geralmente a queda inicia na área fronto-temporal ou vértex;
- não são observados sinais de inflamação no couro cabeludo;
- manejo:
 - homens: minoxidil* 5% em solução hidroalcoólica: aplicar 20 gotas, no couro cabeludo, 2x/dia, com o cabelo seco, contínuo;
 - mulheres: minoxidil* 5% em solução hidroalcoólica: aplicar 20 gotas, no couro cabeludo, 1x/dia, com o cabelo seco, contínuo;
 - explicar que pode haver aumento da queda nos primeiros dois meses de uso;
 - são necessários pelo menos 4 a 6 meses de uso para notar os primeiros resultados;
 - orientar que o uso deve ser contínuo.

Queda de cabelo em atividade:

- **Teste de tração**: tracionar mechas de aproximadamente 50 a 60 fios de cabelo, iniciando-se próximo ao couro cabeludo, em direção distal dos fios. Deve ser realizada em diferentes áreas do couro cabeludo (região frontal, parietal direita e esquerda e occipital). O teste de tração é positivo quando há fácil remoção de 3 a 5 fios em uma única mecha ou 15 fios em 3 mechas.

*Alguns dos medicamentos ou formulações descritas NÃO estão inclusos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023).

Quadro 25 – Investigação e tratamento para urticária crônica.

1º passo: avaliação clínica completa, incluindo anamnese e exame físico.	
• tempo de início da doença; • forma, tamanho, frequência, duração e distribuição das pápulas; • angioedema associado; • sintomas associados, por exemplo, artralgia, febre, diarreia; • história familiar e pessoal de urticária e angioedema; • indução por agentes físicos ou exercícios; • ocorrência em relação ao dia, fins de semana, ciclo menstrual, feriados e viagens; • ocorrência em relação a alimentos ou medicamentos (por exemplo, AINE e inibidores da ECA); • ocorrência em relação a infecções ou outros fatores de estresse; • alergias anteriores ou atuais, infecções, doenças autoimunes, problemas gastrointestinais ou outras condições clínicas; • história social e ocupacional, atividades de lazer; • terapia anterior e resposta, incluindo dosagem e duração; • resultados de procedimentos ou testes diagnósticos anteriores.	
2º passo: exames complementares.	
• Solicitar, de forma rotineira, hemograma com plaquetas, proteína C reativa e velocidade de hemossedimentação (VHS/VSG). • De acordo com anamnese e exame físico, outros exames complementares podem ser solicitados na suspeita de causas secundárias associadas, como por exemplo doenças da tireoide, indicando investigação com TSH.	
3º passo: tratamento da urticária crônica.	
• Afastar possíveis desencadeantes, como por exemplo uso de AINE ou IECA. • Orientar uso fixo de anti-histamínico. • Iniciar anti-histamínico oral de segunda geração, na dose padrão: ○ cetirizina*¹ 10 mg, 1x/dia; ○ levocetirizina*¹ 5 mg, 1x/dia; ○ desloratadina*^{1,2} 5 mg, 1x/dia; ○ loratadina¹ 10 mg, 1x/dia; ○ fexofenadina*² 180 mg, 1x/dia; ○ bilastina*² 20 mg, 1x/dia. • Após 2 semanas, se necessário, aumentar a dose do anti-histamínico para até 4 vezes a dose padrão. Exemplo: levocetirizina* 5 mg, 2 comprimidos, 2x/dia. • Os anti-histamínicos que foram estudados com doses mais elevadas são a desloratadina* e a levocetirizina*, entretanto, na prática clínica, utilizam-se doses maiores das outras medicações. • Após 4 semanas de uso do anti-histamínico em dose máxima (4 vezes a dose padrão), se não houver resposta, o paciente deverá ser encaminhado para avaliação com especialista. • Além disso, considerar associação de montelucaste* 10 mg/dia, bloqueador H2 (evidência baixa) e anti-histamínico de 1ª geração à noite (exemplo: hidroxizina* 25 mg). • Cursos infrequentes de prednisolona em baixa dose (20 a 50 mg/dia, por 7 a 10 dias) são aceitáveis em algumas exacerbações agudas mais graves, que não responderam completamente ao anti-histamínico. ¹Os anti-histamínicos recomendados para gestantes e lactantes são loratadina/desloratadina e cetirizina/levocetirizina. ²Devido à ausência de metabolismo hepático, fexofenadina, desloratadina e bilastina são os anti-histamínicos preferidos em pacientes com doença hepática.	

*Alguns dos medicamentos descritos NÃO estão inclusos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023), adaptado de Zuberbier *et al.* (2018), Bologna, Schaffer e Cerroni (2017) e Criado *et al.* (2019).

Quadro 26 – Investigação e manejo do prurido (sem outras lesões cutâneas).

- Questionar:
 - a) história prévia de doença da tireoide, hepatopatia, nefropatia, HIV/aids, câncer, doença psiquiátrica, entre outras;
 - b) uso de medicações;
 - c) sintomas sistêmicos: febre, perda de peso, sudorese noturna, entre outros;
 - d) presença de prurido nos contatos intradomiciliares.
- Se permanecer sem diagnóstico, solicitar: hemograma, transaminases, fosfatase alcalina, bilirrubinas, GGT, TSH, creatinina, ureia, raio-x de tórax, testes rápidos para HIV, HBV e HCV (ou anti-HIV, anti-HCV e HBsAg).
- Manejo de prurido (sem outras lesões cutâneas):
 - investigação e manejo da doença de base, se identificada;
 - manter a hidratação da pele: uso de sabonetes pouco abrasivos, banhos mornos e rápidos, uso diário de emolientes (preferencialmente, sem fragrância);
 - evitar contato com produtos potencialmente irritantes, como roupas de lã, plantas, produtos de limpeza;
 - identificar e manejar o estresse emocional;
 - não coçar a pele e manter as unhas curtas;
 - anti-histamínicos de 1ª geração (sedativos) podem ser prescritos para o controle do prurido noturno. Devido à sedação, não são bem tolerados durante o dia. Exemplo: dexclorfeniramina, prometazina, hidroxizina*;
 - anti-histamínicos de 2ª geração (não sedativos) são pouco efetivos para o controle do prurido (exceto para prurido relacionado a urticária).

*O medicamento descrito NÃO está incluso na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023).

Quadro 27 – Tratamento para condiloma acuminado¹.Tratamento na Unidade de Saúde:

- **Ácido tricloracético (ATA)*: a 80% a 90% (solução):**
 - aplicar 1x/semana, por até 8 a 10 semanas;
 - aplicar pequena quantidade somente nos condilomas, com auxílio de cotonete ou palito de dentes (uma área esbranquiçada se tornará visível no local da aplicação);
 - aplicar com cuidado, evitando que a solução se espalhe para a pele ao redor da lesão;
 - se o paciente apresentar dor intensa, o ácido pode ser neutralizado com sabão, bicarbonato de sódio ou talco;
 - o tratamento pode ser prescrito durante a gestação.

Tratamento domiciliar:

- **Imiquimod 5% creme:**
 - aplicar nas lesões, 3x/semana, até melhora clínica completa (por até 16 semanas);
 - aplicar antes de dormir e lavar a área pela manhã, com água e sabão (deixar o produto em contato com a pele por 6 a 10 horas);
 - reações locais: eritema, irritação, induração, ulceração, erosões e vesículas. Nesses casos, pode ser dado um intervalo de alguns dias entre as aplicações para diminuir o desconforto do paciente. O tratamento deve ser reiniciado após a melhora dos sintomas;
 - é contraindicado na gestação.

*O medicamento descrito NÃO está incluso na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

¹Orientar sobre a doença, ofertar preservativos e teste para outras IST (HIV, sífilis, Hepatite B e C), avaliar parcerias sexuais.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023), adaptado de Rosen (2022b).

Quadro 28 – Tratamento para verrugas virais¹.

Verrugas vulgares/verrugas palmo-plantares

- Medicamento à base de ácido salicílico (20%) e ácido láctico (15%) em solução colódio elástico 5 mL ou 10 mL* (disponível comercialmente ou sob manipulação):

- a aplicação pode ser feita após o banho ou após deixar o local imerso em água morna por, no mínimo, 5 a 10 minutos;
- lixar, delicadamente, a porção superior da lesão para retirar o excesso de pele (pode ser utilizada uma lixa de unha descartável);
- proteger a pele ao redor da verruga com esparadrapo ou vaselina sólida. Deve ser utilizado esparadrapo, e não micropore;
- aplicar uma camada fina do medicamento sobre a lesão com a pele seca. Esperar secar e cobrir com outro pedaço de esparadrapo, para ajudar a penetração dos componentes;
- trocar esse curativo a cada 24 a 48 horas, tomando o cuidado de repetir todo o procedimento, passo a passo;
- deve-se realizar esse procedimento até o desaparecimento da lesão (período é variável, entre 1 a 3 meses);
- caso ocorra irritação excessiva da pele perilesional, pode-se diminuir a frequência de uso;
- NÃO deve ser utilizado na face e nem em pacientes com neuropatia periférica;
- Em verrugas palmo-plantares podem ser necessárias concentrações mais elevadas de ácido salicílico (até 40%), disponíveis apenas sob manipulação.

- **5-Fluoruracila 5% creme***:

- aplicar 1x/dia, com oclusão, por 4 a 12 semanas;
- é contraindicado na gestação.

Verrugas palmo-plantares

Tratamento na Unidade de Saúde:

- **Ácido tricloracético (ATA)* 50 a 80%:**

- pode ser utilizado em lesões palmares e plantares, aplicando-se com um palito de madeira (se necessário, colocar pequena quantidade de algodão na ponta) a cada 7 a 10 dias, por até 8 semanas;
- pode ocorrer sensação de pinicação e queimação no local durante a aplicação.

Verrugas planas

- **Tretinoína tópica* (0,025%, 0,05% e 0,1%):**

- deve-se utilizar a maior concentração tolerada pelo paciente, sempre à noite;
- é recomendável proteger a pele ao redor com vaselina antes da aplicação;
- caso as lesões sejam em áreas submetidas à depilação com lâminas, orientar paciente a trocar o método depilatório para evitar a disseminação das lesões (optar pelo barbeador elétrico ou creme depilatório);
- é contraindicado na gestação.

- **Imiquimod 5%, tópico:**

- aplicar nas lesões (sem oclusão), antes de dormir e retirar pela manhã, por até 12 semanas;
- é contraindicado na gestação.

Verrugas filiformes

Tratamento na Unidade de Saúde (se material disponível):

- **exérese por shaving e eletrocoagulação:** utilizar anestesia local antes da remoção. A eletrocoagulação é útil tanto para a hemostasia quanto para prevenir a recorrência.

*Alguns dos medicamentos descritos NÃO estão inclusos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

¹Lesões perioculares (com exceção de verrugas planas): evitar os tratamentos tópicos. Encaminhar para avaliação presencial com a Dermatologia.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023).

Quadro 29 – Tratamento para molusco contagioso¹.

- Adultos e adolescentes com lesões genitais devem ser tratados (risco de disseminação sexual).
- O tratamento precoce também está indicado em pacientes imunossuprimidos (risco de lesões disseminadas).
- Nos pacientes imunocompetentes, as lesões desaparecem espontaneamente dentro de 6 a 12 meses, sem deixar cicatrizes.
- Visto a natureza autolimitada da infecção, o tratamento para crianças imunocompetentes é opcional.

Opções de tratamento:

- **Hidróxido de potássio (KOH)* 5 a 10% em solução aquosa (manipulado):**
 - aplicar uma pequena quantidade do produto, com palito de dente, 1x/dia;
 - orientar cuidado para não aplicar na pele sadia perilesional;
 - pode haver sensação de ardência após a aplicação;
 - manter o uso até as lesões ficarem mais avermelhadas e com pequena crosta sobreposta;
 - pode ocorrer hipopigmentação pós-inflamatória.
- **Tretinoína* (0,05% creme ou 0,1% creme ou 0,025% gel):**
 - aplicar nas lesões, em dias alternados, e aumentar gradativamente a frequência do uso conforme a tolerância (podendo chegar a 2x/dia);
 - a aplicação deve ser suspensa quando ocorrer eritema;
 - xerose e irritação são efeitos adversos comuns e esperados;
 - é contraindicado na gestação.

*Os medicamentos descritos NÃO estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

¹Lesões perioculares: evitar tratamentos tópicos. Encaminhar para avaliação presencial com a Dermatologia.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023).

Quadro 30 – Características e tratamento da rosácea.**Rosácea pápulo-pustulosa**

- **Características:** pápulas e pústulas localizadas principalmente na região central da face. Para diferenciar de acne, observar que não há presença de comedões e normalmente o eritema está mais disseminado pela face e não limitado à base das lesões inflamatórias.

- **Tratamento:**

- Para todos os casos:
 - utilizar sabonetes suaves para limpeza da pele; evitar produtos irritativos (tônicos, adstringentes, esfoliantes);
 - uso regular de filtro solar FPS 30 ou maior;
 - hidratantes faciais, 2x/dia.
- Casos leves a moderados:
 - metronidazol* 0,75% gel: aplicar no rosto 2x/dia, por 8 a 12 semanas; ou
 - metronidazol* 1% loção (sob manipulação): aplicar no rosto 1x/dia, por 8 semanas; ou
 - ácido azelaico* 15% gel ou ácido azelaico 20% creme: aplicar no rosto, 2x/dia, por até 15 semanas. Sensação de pinicação após a aplicação do produto é normal e tende a diminuir com o uso; ou
 - ivermectina* 1% creme (sob manipulação): aplicar no rosto 1x/dia, por até 12 semanas.
- Casos moderados a graves:
 - doxiciclina 100 mg, 1 a 2 comprimidos/dia, por 4 a 12 semanas; ou
 - tetraciclina 250 mg ou 500 mg, 2x/dia, por 4 a 12 semanas; ou
 - manter o uso do antibiótico sistêmico até melhora do quadro (máximo de 12 semanas), após manter tratamento tópico com metronidazol* ou ácido azelaico*, para reduzir a chance de recidiva.

Rosácea eritemato-telangiectásica

- **Características:** eritema facial, telangiectasias (nariz e região malar) e episódios recorrentes de flushing, normalmente desencadeados por: extremos de temperatura, exposição solar, bebidas quentes, comidas apimentadas, ingestão de álcool, exercícios e sensação de raiva ou constrangimento. Pele sensível, com queixa frequente de sensação de pinicação e queimação.

- **Tratamento:**

- evitar fatores que desencadeiam o flushing na paciente;
- utilizar sabonetes suaves para limpeza da pele; evitar produtos irritativos (tônicos, adstringentes, esfoliantes);
- uso regular de filtro solar FPS 30 ou maior;
- hidratantes faciais 2x/dia;
- prescrever metronidazol* ou ácido azelaico* 2x/dia (benefício discutível);
- orientar que as telangiectasias não regredem com o tratamento.

Rosácea fimatosa

- **Características:** hipertrofia e espessamento do tecido nasal (rinoíma). Também pode ocorrer em outras áreas (queixo, glabella). Geralmente, homens adultos, com hiperplasia sebácea proeminente e pele muito oleosa.

- **Tratamento:** isotretinoína oral ou procedimento cirúrgico. Encaminhar à Dermatologia.

Rosácea ocular

- **Características:** ocorre em aproximadamente 50% dos pacientes com rosácea. Hiperemia conjuntival, telangiectasias na margem palpebral, blefarite anterior com cílios aderidos e presença de crostas. Hordéolo recorrente e calázio são as manifestações mais comuns.

- **Tratamento:** higiene dos cílios com xampu infantil diluído em água morna, compressas mornas e colírio lubrificante. Antibióticos sistêmicos (tetraciclina, macrolídeos ou metronidazol) para casos mais graves. Encaminhar à Oftalmologia se refratário ao tratamento otimizado por 8 a 12 semanas.

*Alguns dos medicamentos descritos NÃO estão inclusos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023), adaptado de Maier e Helfrich (2022).

Quadro 31 – Tratamento clínico otimizado para melasma.

- Orientar sobre o diagnóstico, explicando que se trata de uma doença crônica e recidivante;
- explicar sobre a importância fundamental das medidas de fotoproteção;
- filtro solar de amplo espectro, com fator de proteção (FPS) maior ou igual a 50, usado diariamente e reaplicado a cada 2 horas, quando exposição ao sol; dar preferência a filtros solares com cor (óxido de ferro) ou sobrepor maquiagem;
- proteção física (chapéu, boné);
- se proteção solar adequada, orientar tratamento ativo com um despigmentante por 3 meses;
- despigmentantes (suspender o uso, temporariamente, se irritação cutânea):
 - associação de hidroquinona 4% + tretinoína 0,05% + fluocinolona acetona 0,01%* creme, à noite, por 8 a 12 semanas (contraindicado para gestantes/lactantes); ou
 - hidroquinona* 4% creme, à noite, por até 12 semanas (contraindicado para gestantes/lactantes); ou
 - ácido azelaico* 20% creme, pela manhã (antes do filtro solar) e à noite.

*Os medicamentos descritos NÃO estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

Fonte: Grimes e Callender (2022).

Quadro 32 – Avaliação e tratamento do vitiligo.

- Discutir a possibilidade de não realizar qualquer tratamento nos pacientes com fototipos I e II ou nos pacientes que não apresentam incômodo estético.
- Sempre orientar proteção solar física (chapéus e roupas) e uso de protetor solar FPS 30 ou maior.
- Solicitar TSH devido à associação entre vitiligo e tireoidopatia.

Tratamento tópico otimizado na APS

- Vitiligo não-segmentar com < 10% da superfície corporal e vitiligo segmentar localizado, com quadro estável:

- Face, região genital ou em áreas de dobras cutâneas:
 - 1ª escolha: inibidores de calcineurina (tacrolimo* 0,1% pomada ou pimecrolimo* 1% creme): aplicar sobre as lesões, 2x/dia, por 6 meses. Se a resposta for efetiva, a terapia pode ser prolongada.
- Lesões corporais (exceto as áreas acima):
 - 1ª escolha: corticoides tópicos. Ex: furoato de mometasona* 0,1% creme, aplicar 2x/dia por 2 meses; realizar pausa por 1 mês e repetir o uso 2x/dia, por mais 2 meses OU aplicar 1x/dia, 15 dias por mês, por um período de 6 meses.

OBS: os pacientes devem ser acompanhados regularmente para avaliar o surgimento de possíveis efeitos adversos do uso dos corticoides tópicos: atrofia cutânea (principal), telangiectasias, estrias, hipertricose e erupção acneiforme.

- **Terapia de manutenção:** os corticoides tópicos e os inibidores de calcineurina podem ser usados 2x/semana, como terapia de manutenção de longo prazo, para evitar as recidivas.

- Vitiligo rapidamente progressivo¹:

- pode ser iniciada prednisona em dose baixa, por até 2 semanas:
 - crianças 5 a 10 mg/dia;
 - adultos 10 a 20 mg/dia;
- se necessário, repetir o curso de prednisona após 4 a 6 semanas;
- encaminhar para avaliação presencial com a Dermatologia.

*Os medicamentos descritos NÃO estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de autonomia e responsabilidade dos gestores estaduais e municipais a pactuação para a sua aquisição e dispensação. Os serviços especializados também não fornecem o medicamento, caso não esteja disponível no SUS.

¹Surgimento abrupto de várias novas lesões ou aumento importante das lesões prévias ao longo poucas semanas/meses.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2023).